

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинин алдындагы
Дары каражаттары жана медициналык
буюмдар департаментинин
директорунун орун басаары
Мамбеталиева Ч.М.

«16»

ноябрь

2021-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

ЦЕЛЕВО

Соодадагы аталышы

Целево

Эл аралык патенттелбеген аталышы

Левифлоксацин.

Дарынын түрү

Инфузия үчүн эритме.

Курамы

100 мл препарат төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат: Левифлоксацинге тете левифлоксацин полугидраты 500 мг

Көмөкчү заттар: натрий хлориди – 900 мг, туз кислотасы – 0,117 мл, натрий гидроксиди – 2,5 мг, туз кислотасы – 0,015 мл, инъекция үчүн суу – q.s. 100 мл ге чейин.

Сүрөттөмөсү

Тунук жашыл-сары эритме.

Фармадарылык тобу

Системалуу колдонуу үчүн микробго каршы препараттар. Системалуу колдонуу үчүн бактерияга каршы препараттар. Бактерияга каршы препараттар–хинолондун туундулары. Фторхинолондор. Левифлоксацин.

АТХ коду: J01MA12.

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы

Фторхинолондор тобундагы кеңири чөйрөдө таасир берүүчү синтетикалык бактерияга каршы каражат, активдүү зат катары левифлоксацин – солго айлануучу офлоксацин изомерин камтыйт. Левифлоксацин ДНК-гиразаны бөгөттөйт, суперспирализация жана ДНК

ажырымдарынын тигиштерин бузат, ДНК синтезин басаңдатат, цитоплазмада, клетка капталдарында жана бактерия мембраналарында терең морфологиялык өзгөрүүлөрдү пайда кылат. Левофлоксацин *in vitro*, ошондой эле *in vivo* шартында көпчүлүк микроорганизмдер штаммдарына карата активдүү.

Сезгич микроорганизмдер (МПК <2 мг/л):

Аэробдук грам оң микроорганизмдер: *Corynebacterium diphtheriae*, *Enterococcus spp.* (анын ичинде *Enterococcus faecalis*), *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus spp.*, коагулаза терс метициллинге сезгич/орточо сезгич (анын ичинде *Staphylococcus aureus* метициллинге сезгич, *Staphylococcus epidermic/is* метициллинге сезгич), *Streptococcus spp.* (С жана G тобу), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pneumoniae* пенициллинге сезгич/ орточо сезгич/ туруктуу, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus spp. viridans* тобу пенициллинге сезгич/ туруктуу.

Аэробдук грам терс микроорганизмдер: *Acinetobacter spp.* (анын ичинде *Acinetobacter baumannii*), *Citrobacter freundii*, *Eikenella corrodens*, *Enterobacter spp.* (анын ичинде *TM. Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter agglomerans*, *Enterobacter cloacae*), *Escherichia coli*, *Gardnerella vaginalis*, *Haemophilus ducreyi*, *Haemophilus influenzae* ампициллинге сезгич/туруктуу, *Haemophilus parainfluenzae*, *Helicobacter pylori*.

Klebsiella spp. (анын ичинде *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*), *Moraxella catarrhalis* (бета- лактамаз итаммдарын иштеп чыгуучу жана иштеп чыгарбаган), *Morganella morganii*, *Neisseria gonorrhoeae* (анын ичинде пеницилиназаны иштеп чыгуучу), *Neisseria meningitidis*, *Pasteurella spp.* (анын ичинде *Pasteurella multocida*, *Pasteurella dagmatis*, *Pasteurella canis*), *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Providencia spp.* (анын ичинде *Providencia stuartii*, *Providencia rettgeri*), *Pseudomonas spp.* (анын ичинде *Pseudomonas aeruginosa*), *Salmonella spp.*, *Serratia spp.* (анын ичинде *Serratia marcescens*).

Анаэробдук микроорганизмдер: *Bacteroides fragilis*, *Bifidobacterium spp.*, *Clostridium perfringens*, *Fusobacterium spp.*, *Peptostreptococcus*, *Propionibacterium spp.*, *Veilonella spp.*

Башка микроорганизмдер: *Bartonella spp.*, *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia psittaci*, *Chlamydia trachomatis*, *Legionella spp.* (анын ичинде *Legionella pneumophila*), *Mycobacterium spp.* (анын ичинде *Mycobacterium leprae*, *Mycobacterium tuberculosis*), *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Rickettsiae spp.*, *Ureaplasma urealyticum*.

Орточо сезгич (МПК >4 мг/л):

Аэробдук грам оң микроорганизмдер: *Corynebacterium urealyticum*.

Corynebacterium xerosis, *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus epidermidis* метициллинге туруктуу, *Staphylococcus haemolyticus* метициллинге туруктуу.

Аэробдук грам терс микроорганизмдер: *Burkholderia cepacia*, *Campilobacter jejuni*, *Campilobacter coli*.

Анаэробдук микроорганизмдер: *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Bacteroides vulgatus*, *Bacteroides ovatus*, *Prevotella spp.*, *Porphyromonas spp.*

Туруктуу (МПК >8 мг/л):

Аэробдук грам оң микроорганизмдер:

Corynebacterium jeikeium, *Staphylococcus aureus* метициллинге туруктуу, башкалар *Staphylococcus spp.* коагулаза терс метициллинге туруктуу.

Аэробдук грам терс микроорганизмдер: *Alcaligenes xylosoxidans*.

Башка микроорганизмдер: *Mycobacterium avium*.

Фармакокинетикасы

Левифлоксациндин фармакокинетикасы сызыктуу мүнөздү алып жүрөт. 500 мг дозада кан тамыр ичине (ТИ) бир жолу куйгандан кийин (60 минута ичинде инфузиялоо) C_{max} $6,2 \pm 1,0$ мкг/мл түзөт. Плазмада туруктуу концентрацияга суткасына 500 мг ичүүдө 48 сааттан кийин жетет жана $6,4 \pm 0,8$ мкг/мл түзөт.

Бөлүштүрүүнүн орточо көлөмү 500 жана 750 мг дозада бир жолу жана көп жолу куйгандан кийин 74-112 л түзөт. Организмдин органдарына жана ткандарына кеңири тарайт, өпкөгө (өпкөдөгү концентрациясы плазмадагыдан 2-5 эсе жогору), колколордун былжырлуу чел кабыгына жана какырыкка, заара жыныс системасынын органдарына, мээ жүлүн суюктугуна жакшы кирет. 24-38 % плазма белоктору менен байланышат (көбүнчө альбумин менен). Плазмада жана заарада стереохимиялык туруктуу, өзүнүн энантиомер, D-оксифлоксацинине айланбайт. Организмде дээрлик зат алмашпайт. 5 % тегерегинде бир аз фармакологиялык активдүүлүккө ээ метаболиттер (десметил, азот оксиди) түрүндө заарада аныкталат. Көбүнчө бөйрөк акрылуу өзгөрүүсүз түрдө заара аркылуу – дозасынын 87 %, 48 саат ичинде жана бир аз заң аркылуу - 4 % азыраак 72 саатта бөлүнүп чыгат. $T_{1/2}$ Т/И куйгандан кийин 6-8 саатты түзөт. Жалпы клиренси 144-226 мл/мин, бөйрөк 96-142 мл/мин түзөт. Бөлүп чыгаруусу түйдөкчөлүү жана түтүкчөлүү секреция жолу менен ишке ашат. Левифлоксациндин фармакокинетикасы бейтаптын жынысына жана курагына көз каранды эмес. Улгайган адамдарда (66 жаштан 80 жашка чейинки курактагы) $T_{1/2}$ бир аз - 7,6 саатка чейин узарат, бирок мында дозасын түзөтүү талап кылынбайт. Бөйрөк функциясынын бузулуулары бар бейтаптарда (креатинин клиренси 50 мл/мин төмөн) топтолуу таасиринен алыс болуу үчүн дозасын түзөтүү талап кылынат. Гемодиализ жана узакка амбулатордук перитониалдык диализ левифлоксацинди организмден бөлүп чыгарбайт, андыктан, аларды жүргүзүүдө кошумча дозаны куюу талап кылынбайт. Боор функциясынын бузулуулары бар бейтаптарда левифлоксациндин фармакокинетикасынын өзгөрүүлөрү күтүлбөйт, себеби ал боордо бир аз гана зат алмашат.

Колдонууга көрсөтмө:

ТИ куюу үчүн Целево левифлоксацинге сезгич козгогучтардан пайда болгон инфекцияларды дарылоо үчүн көрсөтүлгөн:

- бейтапканадан сырткаркы пневмония;
- тери жана жумшак ткандардын кабылдаган инфекциялары;
- заара чыгаруу жолдорунун кабылдаган инфекциялары;
- курч жана өнөкөт бактериялык простатиттин күчөшү;
- күйдүргүнүн жана нозокомиалдык пневмониянын ингаляциялык түрүндө.

Бактерияга каршы дары каражаттарын туура колдонуу боюнча расмий колдонмолорду кароо керек.

Төмөндө саналган абалдары бар бейтаптар үчүн фторхинолондор резервдеги препараттар болушу жана альтернативдүү дарылоо жоктугунда гана колдонулушу керек.

- курч синусит;
- заара чыгаруу жолдорунун кабылдабаган инфекциялары;
- өнөкөт бронхиттин күчөшү.

Каршы көрсөтмө:

- левифлоксацинге, хинолондор тобундагы бактерияга каршы препараттарга же препараттын курамындагы кайсы-бир компонентке жогорку сезгичтик;
- талма;

- фторхинолондорду ичүүгө байланышкан таржымалындагы тарамыш оорулары;
- балдар жана 18 жашка чейинки өспүрүм курак;
- кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгили.

Колдонуу жолу жана дозасы

Бөйрөк функциясы кадимкидей иштеген чоң адамдар үчүн дозасы:

Цевонун сунушталган дозасы ар бир 24 саатта 60 минута бою 500 мг же ар бир 24 саатта 90 минута бою инфузиялоо түрүндө 750мг түзөт. Бул сунуштамалар креатинин клиренси > 50 мл/мин бейтаптарга тиешелүү. Креатинин клиренси <50 мл/мин бейтаптар үчүн дозасын түзөтүү талап кылынат.

Таблица: Бөйрөк функциясы кадимкидей иштеген чоң адамдар үчүн дозасы (креатинин клиренси > 50 мл/мин).

Инфекциянын түрү ¹	Суткалык доза	Узактыгы (күн) ²
Бейтапканадан сырткаркы пневмония	500 мг күнүгө 1-2 жолу	7-14 күн
Заара бөлүп чыгаруу жолдорунун кабылдаган инфекциялары	500 мг күнүгө 1 жолу	7-14 күн
Өнөкөт бактериялык простатит	500 мг күнүгө 1 жолу	28 күн
Тери жана жумшак ткандардын кабылдаган инфекциялары	500 мг күнүгө 1-2 жолу	7-14 күн
Күйдүргүнүн ингаляциялык түрү	500 мг күнүгө 1 жолу	8 жума

Бөйрөк алсыздыгы бар чоң адамдардын дозасын жөнгө салуу:

Бөйрөк алсыздыгында левофлоксацинди этияттык менен колдонуу керек. Дыкат клиникалык көзөмөлдөө жана тиешелүү лабораториялык изилдөөлөр дарылоого чейин жана дарылоо мезгилинде жүргүзүлүшү керек, себеби левофлоксацинди бөлүп чыгаруу жайлашы мүмкүн. Креатинин клиренси > 50 мл/мин болушунда дозасын түзөтүү талап кылынбайт. Бөйрөк функциясы төмөн бейтаптарда креатинин клиренси <50 мл/мин болушунда клиренси төмөн болгондуктан левофлоксациндин топтолушунан алыс болуу үчүн дозасын жөнгө салуу зарыл. *Улгайгандар:* бөйрөк функциясы бузулгандардан сырткары улгайган адамдардын дозасын эч кандай жөнгө салуу талап кылынбайт.

Балдар: левофлоксацин балдар жана өсүп келе жаткан өспүрүмдөр үчүн каршы көрсөтүлөт (18 жаштан төмөн).

Препараттын мультиваленттүү катиондор менен өз ара таасири:

Левофлоксацин инфузиясын мультиваленттүү катиондор, б.а. магний камтыган бардык эритмелер менен аралаштырып бир убакта бир эле кан тамыр аркылуу куюуга болбойт.

1 - аныкталган оору жуктуруучу микроорганизмдерден пайда болгондор.

2- ырааттуу дарылоо (тамыр ичине жана ооз аркылуу) дарыгердин кароосу менен дайындалышы мүмкүн.

Эскертүү: левофлоксацинди кан тамыр ичине тез куюу гипотонияга алып келет жана андан алыс болуу керек. Левофлоксацинди инъекциялоо кан тамыр ичине жайдан жана дозасына жараша 60 минута же 90 минутадан кем эмес куюлушу керек. Эритме түрүндөгү левофлоксацин кан тамыр ичине куюу үчүн гана колдонулат. Булчуң ичине, кекиртект ичине, курсак ичине же тери алдына колдонууга болбойт.

Левофлоксацин алган бейтаптар үчүн гидратация:

Левофлоксацин алган бейтаптарга жогору концентрацияланган зааранын түзүлүүсүн токтотуу үчүн адекваттуу гидратация жүргүзүлүшү керек. Хинолондорду ичүүдө кристаллурия жана цилиндрурия болгон учурлар белгиленген.

Кыйыр таасири

Препаратты сунушталган дозада жана дозалоо режиминде колдонууда көтөрүмдүүлүгү жакшы.

Кездешкен кыйыр реакцияларынын жыштыгын баалоо үчүн төмөнкү критерийлер «тез-тез» (100 дөн 1-10 оорулууларда кездешет), «кээде» (100 дөн 1 оорулуудан азыраак кездешет), «сейрек» (1000 дөн 1 оорулуудан азыраак кездешет), «абдан сейрек» (10 000 дөн 1 оорулуудан азыраак кездешет) жана «айрым учурларда» (бирин-серин учурлар гана сүрөттөлгөн) колдонулат.

Тери жана тери алдындагы клетчатка тарабынан: абдан сейрек – фотосенсибилизация.

Тамак сиңирүү системасы тарабынан: кээде – окшуу, ич өтүү, табиттин жоктугу, кусуу, ичтин оорушу, тамак сиңирүүнүн бузулушу; абдан сейрек – кан аралаш ич өтүү (айрым учурларда бул псевдомембраноздук колиттин белгиси болушу мүмкүн).

Боор тарабынан: аланинаминотрансфераза, аспарагинаминотрансфераза активдүүлүгүнүн жогорулашы; кээде – кан сары суусундагы билирубин деңгээлинин жогорулашы; абдан сейрек – гепатит.

Зат алмашуу тарабынан: абдан сейрек – гипогликемия.

Борбордук жана четки нерв системасы тарабынан: кээде – баш оору, баш айлануу жана/же эркиндиктин жоктугу, уйкусуруо, уйкунун бузулушу; сейрек – колдун манжаларынын сезиминин бузулушу, титирөө, тынчсыздануу, коркуу абалы; карышуу пристубу жана аң-сезимдин чаташуусу, галлюцинация жана чүнчүү тибиндеги психотикалык реакциялар; абдан сейрек – көрүү жана угуунун бузулушу, даам сезүү жана жыт билүү сезгичтигинин бузулушу, тийишкенди сезүүнүн төмөндөшү.

Жүрөк-кан тамыр системасы тарабынан: сейрек – тахикардия, артериялык басымдын түшүшү; абдан сейрек – кан тамыр коллапсы; айрым учурларда – QT аралыгынын узарышы.

Сөөк-булчуң системасы тарабынан: сейрек – муун жана булчуң оорулары; абдан сейрек – тарамыштардын жабыркашы, анын ичинде тендинит, Ахилл тарамышынын үзүлүшү (эки тараптуу мүнөздү алып жүрүшү мүмкүн жана дарылоо башталгандан 48 сааттан кийин байкалат), булчуң алсыздыгы (миастениясы бар оорулуулар үчүн өзгөчө мааниге ээ); айрым учурларда – рабдомиолиз.

Заара бөлүп чыгаруу системасы тарабынан: кээде – кан сары суусундагы креатинин деңгээлинин жогорулашы; абдан сейрек – курч бөйрөк алсыздыгына чейинки бөйрөк функциясынын начарлашы (мисалы, аллергиялык реакция – чарымдуу нефриттин натыйжасында).

Кан жаратуу системасы тарабынан: кээде – эозинофилия, лейкопения; сейрек – нейтропения, тромбоцитопения; абдан сейрек – агранулоцитоз; айрым учурларда – гемолитикалык аз кандуулук, панцитопения.

Аллергиялык реакциялар: кээде – теринин кычышуусу жана кызарышы; сейрек – анафилактикалык жана анафилактоиддик реакциялар (бөрү жатыш, колко карышуусу, ошондой эле – сейрек учурларда – беттин, кекиртектин шишимиктери сыяктуу белгилер менен көрүнгөн); абдан сейрек – артериялык басымдын капыстан төмөндөшү жана шок; айрым учурларда – Стивенс-Джонсон синдрому, токсиндүү эпидермалдык некролиз (Лайелла синдрому) жана экссудативдүү көп түрдүү эритема.

Башкалар: кээде – жалпы алсыздык; абдан сейрек – калтыратма, аллергиялык пневмонит, васкулит.

Сөөк-булчуң системасы жана байланыштыргыч ткандын оорулары.*

Нерв системасынын оорулары.*

Жалпы бузулуулар жана куйган жердеги бузулуулар.*

Психикалык бузулуулар.*

Көрүү органы тарабынан бузулуулар.*

Угуу органы жана тең салмактуулук тарабынан бузулуу.*

* Хинолондор жана фторхинолондорду колдонууга өз ара байланышкан, кээ бир учурларда мурдагы коркунуч факторлорунун болушуна көз карандысыз абдан сейрек, узакка созулган, (бир ай же жылга созулган), инвалид кылуучу, түрдүү, кээде адамдын организминин бир нече системасы жана сезүү органдарына таасир берген потенциалдуу калыбына келбеген олуттуу жагымсыз реакциялары (анын ичинде тендинит, тарамыштардын үзүлүшү, артралгиялар, колу-буттун оорушу, басыктын бузулушу, сезим бузулуулары менен ассоциацияланган невропатиялар, чүнчүү, алсыздык, эс-тутумдун, уйкунун, угуунун, көрүүнүн, даам сезүү жана жыт билүүнүн бузулушу сыяктуу терс реакциялар) өрчүгөндүгү тууралуу билдирүүлөр алынган, кээ бир учурларда мурдагы коркунуч факторлору болушуна көз карандысыз.

Фторхинолондорду кабыл алган бейтаптарда аневризма жана аортанын кабатталышы, кээде үзүлүү менен оордошкон (өлүмгө учураган учурларды кошкондо), регургитация/жүрөк клапанынын жетишсиздиги өрчүгөн учурлар тууралуу маалыматтар алынган.

Ашыкча доза

Симптомдору: аң-сезимдин чаташуусу, баш айлануу, карышуулар, QT аралыгынын узарышы. *Дарылоо* – белгилерине жараша жана колдоочу дарылоо. Бейтап дарыгердин көзөмөлү алдында болушу керек жана тиешелүү суулануу жүргүзүлөт. QT аралыгы узарышы мүмкүндүгүнөн улам кардиограммага текшерүү жүргүзүлүшү керек. Гемодиализ жана перитонеалдык диализ таасирдүү эмес. Атайын антидоту жок.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасирлери:

Фторхинолондорду мультиваленттүү катиондор, мисалы, магний камтыган бардык эритмелер менен бир эле кан тамыр аркылуу бирге колдонууга болбойт.

К витамининин антагонисттери (мисалы варфарин): варфарин жана левофлоксацинди бирге колдонууда протромбиндик убакыт көбөйөт, бул кан агуу көрүнүштөрү менен шартталат. Эгерде левофлоксацин варфарин менен бирге дайындалса протромбиндик убакыт же башка антикоагуляция тесттери дыкат текшерилиши керек.

Диабетке каршы препараттар: хинолондор жана диабетке каршы препараттарды бирге колдонгон бейтаптарда кандагы глюкоза деңгээлинин өзгөрүүлөрү, анын ичинде гипергликемия жана гипогликемия болгондугу тууралуу билдирүүлөр бар. Ошондуктан, бул препараттарды бирге колдонууда глюкоза деңгээлине көзөмөл жүргүзүү зарыл.

Стероиддик эмес сезгенүүгө каршы каражаттар, фенбуфен: стероиддик эмес сезгенүүгө каршы каражаттарды хинолондор, анын ичинде левофлоксацин менен бирге колдонуу БНС дүүлүгүү коркунучун көбөйтүшү жана карышууларга алып келиши мүмкүн.

Теофиллин: левофлоксацинди теофиллин менен бирге колдонуу жарым жартылай бөлүп чыгаруу убактысынын узарышына, сары суудагы теофиллин концентрациясынын жогорулашына жана теофиллин менен байланышкан жагымсыз реакциялардын коркунучунан кийин көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн.

Циклоспорин: левофлоксацин менен бирге колдонууда циклоспориндин концентрациясын бир аз жогорулатат.

Пробенецид жана циметидин: пробенецид жана циметидин сыяктуу бөйрөк аркылуу бөлүнүп чыгууга тиешеси бар препараттар менен левофлоксацинди бирге колдонууда, өзгөчө бөйрөк функциясы төмөн бейтаптар этияттыкты сакташы зарыл.

QT- аралыгын узартуучу препараттар: левофлоксацин башка фторхинолон сыяктуу, мисалы, IA жана III классындагы аритмияга каршы препараттарды, трициклдик антидепрессанттарды, макролиддерди алган бейтаптарга этияттык менен колдонулушу керек.

Дары каражатынын лабораториялык жана диагностикалык көрсөткүчтөргө таасир тийгизүү өзгөчөлүктөрү: кээ бир фторхинолондор, анын ичинде левофлоксацин, опиааттар үчүн изилдөө жүргүзүүдө зааранын жалган-оң анализдерине алып келиши мүмкүн. Ошондуктан өзгөчөрөөк ыкмаларды жүргүзүү зарыл.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Таржымалында хинолон же фторхинолон камтыган дары каражаттарын ичүү менен байланышкан олуттуу жагымсыз реакциялары өрчүгөн бейтаптар Целево препаратын колдонуудан алыс болуу керек. Левофлоксацин менен мындай бейтаптарды дарылоону дарылоонун альтернативдүү варианттары жоктугунда жана пайда/зыянынын өз ара катышын дыкат баалагандан кийин гана баштоо керек.

Узакка созулган, инвалид кылуучу, потенциалдуу калыбына келбеген олуттуу жагымсыз реакциялар:

1000 мг суткалык дозада препаратты ичүү учурларында, хинолондорду же фторхинолондорду алган бейтаптарда, алардын курагына жана мурдагы коркунуч факторлоруна көз карандысыз абдан сейрек, узакка созулган, инвалид кылуучу, потенциалдуу калыбына келбеген түрдүү, кээде адамдын организмнин бир нече системасына таасири бар (сөөк-булчуң, нерв жана психикалык система, сезүү органдары) олуттуу жагымсыз реакциялар өрчүгөндүгү тууралуу билдирүүлөр алынган. Бардык олуттуу жагымсыз реакцияларынын биринчи белгилери жана симптомдору пайда болушунда левофлоксацинди ичүүнү дароо токтотуу жана дарыгерге кайрылуу керек.

Тендинит жана тарамыштардын үзүлүшү

Тендинит жана тарамыштардын үзүлүшү (өзгөчө, ахилл тарамышы), кээде эки тараптуу, хинолондор жана фторхинолондор менен дарылоо баштагандан кийин 48 сааттын ичинде, ошондой эле дарылоону токтоткондон кийин бир нече ай ичинде пайда болушу мүмкүн. Тендинит жана тарамыштардын үзүлүшүнүн өрчүү коркунучу улгайган бейтаптарда, бөйрөк

алсыздыгы, паренхиматоздук органдардын трансплантациясы бар, кортикостероиддер менен бир убакта дарылоо алган бейтаптарда жогорулайт. Кортикостероиддерди жана фторхинолондорду бир убакта колдонуудан алыс болуу керек.

Тендиниттин биринчи белгилери пайда болушунда (мисалы, ооруксунган шишимик, сезгенүү) Целево препаратын ичүүнү токтотуу жана альтернативдүү дарылоону кароо керек. Жабыркаган кол-бутту (кол-буттарды) тиешелүү негизде дарылоо керек. Тендинопатиянын белгилери пайда болушунда кортикостероиддерди колдонбош керек.

Четки нейропатия

Хинолондорду жана фторхинолондорду кабыл алган бейтаптарда парестезия, гипостезия (төмөн сезгичтик), дизестезия же алсыздыкка алып келүүчү сенсордук же сенсомотордук полинейропатия учурлары тууралуу маалымдалган. Целево препаратын кабыл алган бейтаптарга эгерде оору, ачышуу, сайгылашуу, сенейүү же алсыздык сыяктуу невропатия симптомдору өрчүсө коркунуч келтирген калыбына келбеген абалдардын өрчүшүн алдын алуу үчүн дарылоону улантардын алдында өзүнүн дарыгерине маалымдоону сунуштоо керек.

Аневризма жана аортанын кабаттанышы регургитация/жүрөк клапанынын жетишсиздиги
Эпидемиологиялык изилдөөлөрдө фторхинолондорду колдонгондон кийин аневризма жана аортанын кабаттанышы, өзгөчө улгайган курактагы бейтаптарда аорталык жана митралдык клапандын регургитациясы өрчүү жогору коркунучу тууралуу маалымдалган. Фторхинолондорду колдонгон бейтаптарда аневризма жана аортанын кабаттанышы, кээде үзүлүү менен оордошкон, (анын ичинде өлүмгө учураган учурлар), регургитация/ жүрөк клапандарынын жетишсиздиги өрчүгөндүгү тууралуу маалыматтар алынган.

Фторхинолондорду пайда-коркунуч катышын дыкат баалагандан кийин гана жана таржымалында аневризмасы же жүрөк клапанынын тубаса кемтиги бар, же аневризмасы жана/же аортанын кабаттанышы же жүрөк клапанынын оорулары бар, ошондой эле алардын өрчүшүнө түрткү берүүчү башка төмөнкү коркунуч факторлору же абалдары бар бейтаптарда дарылоонун башка альтернативдүү варианттарын кароодон кийин колдонуу керек:

- бир убакта аневризмасы жана/же аортанын кабаттанышы, жана регургитация /жүрөк клапанынын жетишсиздиги (мисалы, Марфан синдрому же Элерс-Данлос синдрому, Тернер синдрому, Бехчет оорусу, гипертония, ревматоиддик артрит сыяктуу тутумдаштыргыч ткандын патологиясы, же,

- аневризма жана аортанын кабаттанышы (мисалы, Такаясу артериити же гигант клеткалык артериит, же белгилүү атеросклероз, же Шегрен синдрому сыяктуу кан тамыр оорулары), же
- регургитация / жүрөк клапанынын жетишсиздиги (мисалы, инфекциялык эндокардит).

Бир убакта системалуу кортикостероиддерди кабыл алган бейтаптарда аневризма жана аортанын кабаттанышы, жана анын үзүлүүдөгү өрчүү коркунучу.

Капыстан ичте, төштө же аркада оорунун пайда болушунда бейтаптар дароо тез жардам бөлүмүнө кайрылуусу керек.

Бейтаптарга курч антигүү, жүрөктүн тез кагышынын жаңы приступу, ичтин же буттардын шишимиги учурларында дароо медициналык жардамга кайрылууну сунуштоо керек.

Препаратка бактериялык туруктуулуктун өрчүшүн азайтуу жана левофлоксацин жана башка бактерияга каршы каражаттардын таасирдүүлүгүн колдоо үчүн, Целево инфузиялык эритмеси сезгич бактериялардан пайда болгон инфекцияларды дарылоо жана алдын алуу үчүн гана колдонулушу керек. Культура уругунун натыйжасы белгилүү жана микроорганизмдердин сезгичтиги аныкталган болсо, бактерияга каршы дарылоону тандоого түзөтүү жүргүзүү зарыл.

Мындай маалыматтар жоктугунда жергиликтүү эпидемиология жана кабылдагычтыктын үлгүлөрү дарылоонун эмпирикалык тандоосуна өзүнүн салымын кошуусу мүмкүн.

Бул топтогу башка каражаттар сыяктуу эле Целево менен дарылоо мезгилинде *Pseudomonas aeruginosa* туруктуулук өрчүшү мүмкүн. Дарылоо мезгилинде мезгил-мезгили менен аткарылуучу культура уругун жана сезгичтикти аныктоо, бактерияга каршы каражатка оору жуктургуч микроорганизмдердин узакка кабыл алгычтыгы тууралуу жана ошондой эле бактериялык туруктуулуктун пайда болуу мүмкүндүгүнөн маалымат берет.

Инфузия үчүн Целево (инфузия үчүн левофлоксацин) сезимтал микроорганизмдерден пайда болгон (> 18 жаш) ашыкча эмес, орточо, жана оор инфекциялары бар чоң адамдарды дарылоо үчүн дайындалган. Инфузия үчүн левофлоксацин дарысын бейтап ооз аркылуу кабыл ала албаган шартта кан тамыр ичине куюу үчүн көрсөтүлгөн.

Тендинит же тарамыштардын үзүлүшүнүн биринчи белгилеринде бейтаптарга эс алууну же антибиотик кабыл алууну сунуштоо зарыл.

Өтө сезгичтик реакциясы: левофлоксацин дарылоосун алып жаткан бейтаптарда олуттуу, кээде фаталдуу аллергиялык же анафилактикалык реакциялар болушу мүмкүн. Мындай учурларда Целево эритмесин инфузиялоо дароо токтотулушу керек.

Гепатотоксинуудулук: табиттин жоктугу, сарык, күңүрт заара, кычышуу сыяктуу белгилери өрчүгөн учурларда бейтаптарга дарылоону токтотуу зарыл.

Борбордук нерв системасындагы таасирлери: Целево борбордук нерв системасынын (БНС) оорулары белгилүү болгон же күмөн саналган бейтаптарга карата аларды карышууга жакындатышы же карышуу даярдыгынын чегин төмөндөткөндүктөн этияттык менен колдонулушу керек (мисалы, мээ кан тамырларынын артериосклерозу, талма). Фенбуфен, жана ага окшош стероиддик эмес сезгенүүгө каршы каражаттар мээ сезгичтигинин алдын төмөндөтөт. Мындай учурларда Целево препараты менен дарылоо токтотулушу керек. Целевону колдонууда клостридиум диффициле-ассоциацияланган ич өтүү өрчүшү мүмкүн, жана орточодон фаталдуу колитке чейин өрчүшү мүмкүн. Мындай абалдарда препарат менен дарылоо токтотулушу керек.

Четки нейропатия: эгерде бейтап нейропатия белгилерин, анын ичинде оору, сезгенүү, сайгылашуу, сезгичтиктин төмөндөшү жана/же алсыздык же башка сезгичтиктин өзгөрүшү, анын ичинде жарыкка сезгичтик, ооруу, дене табы, баш айлануу сезимин сезсе калыбына келбеген абалды өрчүшүн алдын алуу үчүн токтотулушу керек.

QT аралыгынын узарышы: QT аралыгынын узарышы белгилүү болгон, гипокалиемиясы бар бейтаптар жана IA класстагы (хинидин, прокаинамид), III класстагы (амиодарон, соталол) аритмияга каршы каражаттарды, макролиддерди алган бейтаптарга левофлоксацинди колдонуудан алыс болуу керек. Улгайган бейтаптар QT аралыгынын узарышынын дарыга – ассоциацияланган таасирине көбүрөөк сезгич болушу мүмкүн. Глюкоза-6-фосфат дегидрогеназа жетишсиздиги бар, глюкоза-6-фосфат дегидрогеназасы жабык же кемтиктери бар бейтаптарда хинолон катарындагы бактерияга каршы каражаттарды колдонууда гемолитикалык реакциялар болушу мүмкүн жана ошондуктан левофлоксацин аларга этияттык менен колдонулушу керек.

Дары каражатынын унаа каражаттарын же потенциалдуу коркунуч келтирген механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасир тийгизүү өзгөчөлүктөрү:

Жагымсыз таасирлери (мисалы, баш айлануу, уйкусуроо, көрүүнүн бузулушу) бейтаптын көңүл буруу жана реакция кылуу жөндөмдүүлүгүн начарлатышы мүмкүн жана ошондуктан бул жөндөмдүүлүктөр (мисалы, автоунаа айдоо же операциялык машиналар менен иштөө)

өзгөчө мааниге ээ болгон абалдарда коркунуч келтириши мүмкүн. Ошол себептен жогорку көңүл буруу жана психомотордук реакциянын тездигин талап кылган иштерден кармануу керек.

Чыгаруу формасы

100 мл флакондо инфузия үчүн эритме.

Бир флакон колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон таңгакта.

Сактоо шарты

Кургак, жарык тийбеген жерде, 25°C дан жогору эмес аба табында сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл.

Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Дарыгердин рецепти менен.

Каттоо күбөлүгүнүн ээси

Vegapharm LLP

Astra House, Arklow Road,

London, England SE14 6EB, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү

Aishwarya Healthcare

Vill. Thana, Baddi, Nalagarh,

Distt. Solan (H.P.), India (Индия)

**Кыргыз Республикасынын аймагында керектөөчүлөрдөн өндүрүмдүн (товардын)
сапаты боюнча арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги**

«Aman Pharm» ЖЧК (Аман Фарм), Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шоорук көч. 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com